UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Neurologie
Examen physique syndrome Guillain-Barré
Avec patient
Avec geste clinique

Nom du rédacteur : Dubruque Axel **Date de rédaction : 06/12/23**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 121 – Déficit neurologique récent

Domaine de compétence principal (en sélectionner 1 SEUL) : Examen clinique

Domaine de compétence secondaire (en sélectionner 1 SEUL) : Urgence

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Caractériser la sémiologie du déficit neurologique et l'intégrer dans un tableau neurologique

2- Chercher des éléments de gravité généraux et/ou fonctionnels

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (préciser genre si pertinent) (préciser tranche d'âge)

Matériel nécessaire à la station

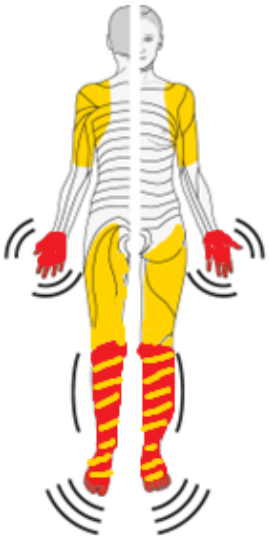
- Mannequin NON
- Brancard OUI
- Stéthoscope, Marteau réflexe

Instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synospis :
Vous avez 58 ans et vous consultez aux urgences car vous présentez depuis quelques jours des fourmillements des membres inférieurs qui sont remontées jusqu'aux genoux avec des difficultés à monter les escaliers ou se relever d'une chaise.
Un étudiant en médecine va vous examiner (pas d'interrogatoire)

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Greg Prénom : Kong Age : 58 ans Youtubeur Marié, 3 enfants Maison
Antécédents	Infection respiratoire il y a 2 semaines
Médicaments actuels/ Toxiques	*Aucun*
Etats d'esprit/ comportement	Posture allongée Douleur : faible Angoisse : faible Colère : faible Autre : **Voix nasonnée aux cours de l'examen (si possible)**
Déroulement du scénario	Vous êtes allongé Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Ex : "**Depuis quelques jours, je ressens des fourmillements qui ont commencé aux pieds et qui sont montés jusqu'au genou avec de plus en plus de mal à monter les escaliers, aujourd'hui les mêmes symptômes sont apparus dans les mains j'ai alors appelé les urgences et maintenant que je suis ici j'ai l'impression de ne plus sentir mes jambes"***

	Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. Il doit normalement vous examiner. Laissez-vous guider. Lorsque qu'on vous demande si vous sentez vos doigts de pieds vous dites **« J'ai l'impression de ne plus les sentir »** Lorsque le médecin vous demande de lever la jambe vous dites **« Je n'y arrive pas »**. Lorsque le médecin vous demande de lever les bras vous y arrivez mais avec difficulté, cependant **lorsque qu'on vous impose une résistance vous échouez** **Voici un schéma pour vous aider à comprendre votre situation : en rouge le déficit sensitif, en jaune le déficit moteur (quand c'est rayé c'est qu'il y a les deux moteur et sensitif), les trait noirs sont des ataxies**  **En gros votre monsieur ne peut plus relever le petit orteil, ni faire de flexion dorsal du pied, ni faire de flexion plantaire du pied, ni fléchir/étendre sa jambe, ni fléchir/étendre sa cuisse. Il a un déficit moteur MRC 3 en levant les bras. Et comme il a une légère atteinte bulbaire, il a une voix nasonnée.** **Il a une ataxie proprioceptive des jambes et des mains**
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Où se situent vos picotements	Du pieds jusqu'au genou
Avez-vous des douleurs	Oui de temps en temps j'ai l'impression d'avoir des décharges électriques là où ça picote
Pouvez-vous marcher	Je n'y arrive pas docteur
Arrivez vous à bouger vos jambes	Non je n'y arrive pas
Avez-vous des antécédents	Aucun, mis à part une bronchite il y a 2 semaines
Est-ce que vous fumez/buvez	Non
Avez-vous du mal à respirer ?	Non ça peut aller
Avez-vous l'impression que votre voix a changée dernièrement	Oui maintenant que vous le dite ma femme m'a dit que j'avais la voix nasonné
Avez-vous des difficultés à avaler ?	Oui j'ai du mal avec l'eau

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne de neurologie aux urgences de pasteur, vous venez pour Mr Kong 58 ans qui depuis plusieurs jours présente un déficit moteur et sensitif aux quatre membres accompagné d'une dysphonie.

Il n'y a pas de notion de traumatisme et a pour seul antécédent une infection respiratoire il y a 2 semaines.

Consta ntes :

Glycémie : 0,9 g/L FC : 90 bpm PA : 95/60 mmHg T°C : 37,2

Sat : 92 % en air ambiant

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser un examen physique ciblé sur les symptomes du patient
2. Préciser si les symptomes s'intégrent dans un syndrome neurologique périphérique ou central
3. Donnez votre hypothèse diagnostique principal et citer explicitement les signes de gravités à rechercher

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche la présence de réflexe ostéotendineux	
Recherche le Babinski	
Recherche des signes d'ataxie proprioceptive (pallesthésie ou arthrokinesthésie)	
Recherche un déficit moteur proximal aux membres (Mingazzini et épreuve des bras tendus)	
Demande la fréquence respiratoire du patient	
Parle d'un déficit sensitif bilatéral et symétrique	
Tache 2	
Parle d'un syndrome neurogène périphérique	
Tache 3	
Suspecte en premier lieu le diagnostic de Guillain barré ou de polyradiculonévrite	
Recherche un trouble respiratoire comme facteur de gravité	
Recherche un trouble de la déglutition comme facteur de gravité	
Recherche d'une dysphonie comme facteur de gravité	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE	1 à 5
APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE	
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	

Préciser quand l'examinateur doit intervenir pour donner un signe clinique positif :

UNIQUEMENT LORSQUE L'ETUDIANT REALISE LA MANŒUVRE SPECIFIQUE ou qu'il le demande à l'examinateur en décrivant ce qu'il veut faire.

- Test de la sensibilité : Déficit à tous les modes, à tout le membre inférieur et aux mains
- Manœuvre de Mingazzini impossible
- Epreuve des bras tendus ou Barré possible contre pesanteur mais échoue contre résistance
- Réflexe Rotulien aboli
- Réflexe Achilléen aboli
- Réflexe Bicipital aboli
- Réflexe Tricipital aboli

- Babinski négatif
- Recherche d'ataxie : Le patient se trompe dans le sens de position du gros orteils et des doigts de la main
- Diminution de la pallesthésie distale des membres inférieures
- Paires crâniennes intègres : I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, XII
- Paire crânienne atteintes : IX, X, XI lorsqu'il recherche une paralysie des voiles du palais ou un signe du rideau
- Si recherche de dysphonie lui dire : « confirmation d'une dysphonie par ses proches »
- Signe du rideau positif
- Pas de trouble sphinctérien

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche la présence de réflexe ostéotendineux	5
Recherche le Babinski	5
Recherche des signes d'ataxie proprioceptive (pallesthésie ou arthrokinesthésie)	3
Recherche un déficit moteur proximal aux membres (Mingazzini et épreuve des bras tendus)	5
Demande la fréquence respiratoire du patient	5
Parle d'un déficit sensitif bilatéral et symétrique	5
Tache 2	
Parle d'un syndrome neurogène périphérique	5
Tache 3	
Suspecte en premier lieu le diagnostic de Guillain barré ou de polyradiculonévrite	5
Recherche un trouble respiratoire comme facteur de gravité	5
Recherche un trouble de la déglutition comme facteur de gravité	3
Recherche d'une dysphonie comme facteur de gravité	5
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE	1 à 5
APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE	
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	